第十六章 医学无法解释症状的全科医学处理

本章数字资源

学习提要

医学无法解释症状是社区和医院门诊常见症状之一，症状类型多、病因复杂和涉及的因素多，机制尚不明确。全科医师在处理医学无法解释症状过程中涉及的主要内容包括：医学无法解释症状概念、临床特点、病史采集的全科医学思维、重点体格检查、合理的辅助检查、诊断基本原则、鉴别诊断思路、基层对患者评估和处理、转诊的指征、个性化治疗（药物、非药物和行为认知）、全科医疗及健康管理。

医学无法解释症状（medically unexplained symptoms，MUS）是指经过患者就诊和合理检查后，运用现有的医学机制仍无法进行合理解释的症状。医学无法解释症状特指经过详细的病史采集、合理的检查、排除症状相关器质性疾病以及排除重要疾病的预警症状后，这些症状仍然无法找到充分的疾病依据；有人将其称为医学无法解释的躯体症状（medically unexplained physical symptoms，MUPS）。这些症状包括躯体和功能的症状，见于各个系统、器官的器质性疾病或者某些精神疾病。

医学无法解释症状的患病率尚缺乏确切的流行病学资料，在我国，因医学无法解释症状就诊者见于全科医学门诊、各个专科门诊、社区卫生服务中心门诊，在国外的医院门诊、初级卫生保健门诊也有此类患者就诊，患病率从 30% 到 65% 不等；女性的患病率和就诊次数高于男性；其中可以用器质性疾病合理解释的不到 20%。

部分医学无法解释症状患者往往因为没有器质性疾病来合理解释而反复就诊，患者不仅承受症状的痛苦，还常对医疗的过程及结果不满意。卫生经济学的研究资料显示，患者反复就诊的行为会导致医疗资源消耗增加，是造成个人、家庭和社会负担增加的主要原因之一。

临床案例

主观资料（S）：患者，女性，45 岁。因“乏力 7 个月余”，多处、多次就诊，现再次至全科医学门诊就诊。

【问题 1】作为一名全科医师，接诊以“乏力”为主诉、曾多次就诊的患者，应了解哪些情况？

医学无法解释症状呈现多样化，患者因各种症状就诊于不同医疗机构和医学专科，除了全科医学科，就诊的专科常涉及呼吸内科、心血管内科、神经内科、消化内科甚至心理科等；患者因其症状无法明确须就诊的专科，常往返于不同专科诊室；就诊后因无法得到合理的解释，以及缺乏患者的认同，患者常被建议转诊到不同专科。常见的医学无法解释症状见表 16-1。

表 16-1 常见的医学无法解释症状

分类	症状
全身性症状	乏力、全身性疼痛、睡眠障碍、消瘦、出汗、感觉异常（如烧灼感、冰冷感）
头颈部症状	头痛、头晕、耳鸣、眩晕、晕厥、口苦、口干、嗅觉异常、颈部僵硬

续表

分类	症状
胸部症状	心悸、气短、胸闷、烧心感、慢性胸痛
腹部症状	腹胀、腹痛、恶心、食欲缺乏、尿频、大便习惯改变
躯干四肢症状	腰背痛、腰腿痛、关节痛、麻木、下肢水肿
多症状共存	肠易激综合征、慢性疲劳综合征、纤维肌痛综合征

医学无法解释症状呈现多样化：可能是躯体器质病变的伴随症状，也可以是功能性躯体综合征（functional somatic syndromes）的表现，或者是因心理问题导致的行为方式改变。医学无法解释症状兼具普通医学（medicine）和精神病学（psychiatry）的表现，具有“二重性”，这些症状有时候难以确定是归属于功能及躯体的症状还是精神的症状。

知识点

医学无法解释症状的发病机制

医学无法解释症状的机制尚不明确，在生物医学方面，症状可以涉及多个系统，但缺乏病理生理学、生物医学的确切发病机制，没有相关病理学或者相应生物标志物证据，由于病因复杂，涉及因素多，目前认为与生物、心理及社会因素密切相关。

1. 常见的影响发病的因素除了生理、性别、年龄因素，还有健康观、社会角色、心理因素、情感状态、潜在的人格特征以及外界刺激因素等。

2. 女性患病率高于男性，可能跟女性的生理因素、家庭婚姻关系、社会功能等方面有关。有些症状在绝经前后多见，如出汗、皮肤发烫或冰冷的感觉、烦躁、易怒、睡眠障碍等，女性的症状数量、就诊次数、就诊门诊科室数等多于男性，可能是由激素水平改变和自主神经功能紊乱所致。

3. 部分非器质性慢性疼痛的发病机制被认为是神经“敏化”。慢性疼痛所致的中枢敏化，是由于外周反复刺激产生疼痛，通过增强疼痛信号传输通路，同时下调疼痛阈值，从而放大反复输入的刺激信号，导致中枢对刺激的敏感性增加而疼痛感增强。此外，内脏神经敏化与肠易激综合征的腹部不适症状发生有关。

4. 某些有器质性疾病的患者的症状，常被夸大、臆想，患者甚至认定症状与非真实存在的疾病症状相关联，但用该疾病及其并发症都无法合理解释，多见于有情感障碍、焦虑症、抑郁症患者。

【问题 2】作为一名全科医师，接诊以乏力为主诉、曾多次就诊的患者，应如何采集病史？

有效沟通是获取翔实病史的基础，全科医师在病史采集过程中，对于此类患者，除注意提问技巧，还须具有共情（empathy）心理，尽量倾听和鼓励患者诉说，利于在有限时间内收集到有意义的内容，也利于医生和患者建立信任关系，帮助患者恢复信心。

思路 1：首先了解此次症状发生的诱因：乏力症状发生的可能诱因，包括劳累、睡眠、饮食情况、情绪变化、气候环境改变、社会关系失调等。

思路 2：症状的特点：了解症状的发作性、周期性、间歇性，有无规律性，持续时间和轻重程度，缓解方式或加剧症状的因素。症状的特点，有利于判断症状关联的系统或器官以及病变的部位、范围和性质。

思路 3：症状的发展与演变：症状的性质变化或新的症状出现，如在乏力的基础上又出现一系列的新的症状。这些症状常常是鉴别诊断的依据，或提示出现了其他疾病。

思路 4：是否伴随其他症状：除主要症状，伴随的其他症状及其特点、发生时间，以及相互的关联和影响。当伴随的症状比较多、病程较长时，根据主要症状进行重点了解。

NOTES

思路 5：既往病史，是否存在基础疾病，这些疾病与现症状的关系。了解与症状有关的基础病因，如糖尿病、冠心病等慢性疾病或者近期新发病痛，对患者的猜测、先入为主的说法或众多原因，应进行梳理、科学分析。

思路 6：既往诊治情况：症状出现后的就诊情况，包括检查结果、诊断和治疗过程、治疗药物或方法、疗效和就诊医院级别、就诊次数等。用药情况：询问是否使用处方药、非处方药、中成药、保健品甚至毒麻药等，尤其是对可疑药物所致的症状，除了解药物名称，还应询问使用时间长短、与症状发生的关联情况。

思路 7：个人、家庭和社会情况：全科医生应关注患者的个人情况，如性格、嗜好、幼时特殊经历、婚姻情况、工作性质和工作压力等，此外还要了解家族史、经济情况、与家庭成员相处情况、社会因素等。

知识点

医学无法解释症状的特点

1. 症状复杂、多样化，症状可单一出现，也可以多个症状共同存在，不同症状、症状不适程度时常有变化。

2. 症状发生和持续的时间不定，可持续数天、数月甚至数十年，可持续出现或间断发生，可合并基础疾病，甚至多种疾病共患，但与其原发疾病关系不明确。

3. 患者多次或多处就诊及检查后，诊断仍不确定或者诊断名称模糊多样，患者难以信服。如腹胀，诊断的名称多样，如慢性胃肠炎、功能性胃肠病、肠易激综合征、自主神经功能紊乱等。

4. 患者就诊后对治疗效果满意度差，但仍有就诊意愿而且频繁就诊，影响其正常的生活、工作、学习或社会角色。

5. 这些症状缺乏生物标志物和辅助检查的疾病证据，机制尚不明确，涉及多种影响因素，与生物、心理及社会因素密切相关。

临床病例（续）

主观资料（S）：患者，女性，45 岁。因“乏力 7 个月余”至全科门诊就诊。

通过进一步采集病史，了解到以下情况。

现病史：患者自述受凉后出现感冒症状，1 周后鼻塞、咳嗽、咽痛、发热好转，继续在家休息 1 个月后上述症状消失，但逐渐出现乏力、犯困，轻微活动时感觉无力和四肢肌肉酸胀疼痛不适感，无法专注工作。睡眠不深，睡眠后仍然觉得精力差。发病以来 2 次就诊于社区卫生服务中心、就诊于 3 家医院，分别就诊于中医科、全科医学科、心血管内科、消化内科、妇科专科，并进行多项检查，未明确诊断。症状时好时坏，饮食及二便可，无畏寒、关节疼痛、水肿，无体重下降。

既往史：否认传染病、慢性病史、长期服药史。

个人史：月经不规律，经期缩短，性格内向喜静，不爱运动，否认饮酒，嗜好饮用咖啡。

婚育史：已婚，孕 2 产 1 儿。

家族史：父母健在，否认慢性疾病及精神疾病。

家庭及社会情况：自觉经济上有压力，但夫妻及家庭成员关系良好，家庭支持患者就医，小孩就读初中，患者就职于私营培训机构，近来觉得工作能力差，社会人际关系良好。

【问题 3】该患者的病例特点是什么？

该病例特点为：患者为中年女性，因乏力 7 个月余就诊；患者伴有精神不振、睡眠障碍、肌肉酸痛等多个症状；症状反复出现；多次就诊，无法确诊，满意度差，影响生活工作质量。无基础疾病和长期

NOTES

药物使用史;曾多次检查,结果无生物标志物或病理学意义,没有能明确疾病的客观依据。根据医学无法解释症状的临床特点,初步考虑乏力属于医学无法解释症状。

【问题 4】以乏力为主诉的症状,需要注意与哪些疾病鉴别?

思路 1:主要与症状相关的各个系统、器官的器质性疾病鉴别。

乏力可见于很多疾病。如,血液系统:贫血、白血病。心血管系统:高血压、冠心病、慢性心功能不全。内分泌系统:糖尿病、甲状腺功能减退症、肾上腺皮质功能减退症。免疫系统:干燥综合征、类风湿关节炎。神经系统:多发性硬化、吉兰-巴雷综合征。呼吸系统:慢性阻塞性肺疾病、间质性肺炎、睡眠呼吸暂停综合征。消化系统:肠易激综合征、慢性肠炎、肝硬化。泌尿系统:慢性肾炎。感染性疾病:结核病、慢性乙型肝炎。肿瘤(胃癌、肺癌)、重金属或药物中毒、药物或酒精依赖等。

思路 2:精神疾病所致的症状

经反复就诊及检查,仍未发现异常,并且伴有焦虑或者抑郁情绪,首先应与躯体形式障碍鉴别,其次与抑郁障碍、焦虑障碍、精神分裂症鉴别。建议采用相关量表详细评估是否存在精神心理问题,使用快速筛查工具量表对患者是否存在精神障碍进行初步筛查。常用的筛查评估量表有焦虑自评量表、抑郁自评量表、躯体化症状自评量表。

思路 3:药物性或成瘾性物质引起的症状

药物存在一些不良反应,常见有苯二氮䓬类药物、抗抑郁药、抗精神病药物,抗高血压药、调脂药和其他非处方药物(包括减肥药、草药)等,根据用药史、与症状出现的关联性可鉴别诊断。此外酒精依赖和药物滥用(吗啡、大麻、苯丙胺类药物等),可根据使用史鉴别。

知识点

1. 医学无法解释症状诊断的基本原则是排除性诊断:排除疾病的早期症状,疾病的潜在症状,严重疾病的预警症状,并与其他疾病,尤其与精神疾病或药物所致的症状相鉴别。

2. 对于长期反复出现的症状,关注症状的性质是否发生变化、程度是否加重、发生频率是否改变,如慢性胸痛。

3. 多个症状共存,重点关注内在联系,是否符合疾病的一元论原则,然后考虑合并其他疾病,除器质性、功能性疾病,还应考虑社会心理因素引起的疾病。

4. 如有基础疾病的症状,是否可用原发病进行合理解释,尤其是慢性疾病合并症及其伴随症状。如糖尿病患者在原有症状基础上,新发乏力症状,应进行详细病史采集及合理检查,作出疾病诊断。

5. 在疾病过程中如果症状加重或出现新的症状,应再次检查和评估,以发现或排除器质性疾病。如乏力患者伴有胸闷,反复出现,影响正常的生活、工作,应重视是否有心血管疾病等。

【问题 5】完成病史采集后,提出临床假设(初步诊断),下一步应重点完成哪些体格检查并进行乏力严重程度评估?

思路 1:体格检查应包括常规检查:患者的生命体征(血压、脉搏、呼吸、体温);皮肤黏膜有无苍白、黄染等;是否存在贫血、黄疸;全身浅表淋巴结有无肿大,是否存在感染及肿瘤;甲状腺大小及质地等情况;做肺部、腹部、心脏等体格检查,是否存在肺部啰音,有无肝脾大、腹部包块,有无心律不齐、心脏杂音等异常体征。

重点检查:观察舌头是否居中,额纹是否对称,双侧瞳孔大小及对光反射,有无肌肉萎缩,步态、皮肤感觉、肌力及肌张力有无异常,腱反射是否减弱,是否有神经、肌肉病变。此外,对于伴随症状也须做相应的重点查体。

思路 2:通过疲劳量表评估乏力严重程度,包括一般性疲劳、体力疲劳、活动减少以及脑力疲劳多个维度的评估,根据每个维度的问题进行打分,总分越高代表乏力程度越严重。

NOTES

临床病例（续）

客观资料（O）：

体格检查：体温 37.2℃，脉搏 90 次/分，呼吸 20 次/分，左右上肢血压 130/80mmHg；BMI 25kg/m^2。神清，无贫血貌，全身皮肤巩膜无黄染，浅表淋巴结未触及肿大，甲状腺无肿大，双肺呼吸音清；心率 90 次/分，律齐，心脏听诊无杂音；颈部、腹部血管听诊无杂音；腹软无压痛，肝脾肋下未触及；双下肢无水肿。神经系统检查：颈软，伸舌居中，双侧瞳孔等大等圆，对光反射灵敏，四肢、躯体皮肤感觉无异常，肌力及肌张力两侧对称、无增高或减低，腱反射均存在，病理征未引出。

生化检查：血常规、尿常规、甲状腺功能、肝功能、肾功能、血糖、血脂无异常，心电图无异常。

【问题 6】结合上述主观材料（S）及客观资料（O），对患者的初步评估（A）是什么？

思路：该患者为中年女性，主诉乏力，结合病史采集、临床特点、体格检查和实验室检查，考虑乏力属于医学无法解释症状。

【问题 7】该患者在基层应如何评估和处置（P）？

临床病例（续）

处置计划（P）：①风险评估及处置；②个性化治疗；③健康教育、制订随访计划；④必要时转诊，进一步完善检查和治疗。

思路 1：全科医疗中基层评估：对于医学无法解释症状进行风险评估，有利于合理的治疗及后续管理。风险评估包括：预期是否有生命危险，是否仍有严重疾病尚未排除，是否严重影响生活质量，是否有潜在的严重的医患关系冲突等社会问题。

思路 2：根据评估情况，为患者制订诊疗计划及复诊计划，嘱咐患者如症状性质、严重程度、频率发生改变，尤其是出现严重疾病的预警症状，应及时就诊。如果患者出现症状加重、性质改变或者有新发症状，特别是出现生命体征不稳定，应重新评估，以利于器质性疾病诊断。同时充分利用家庭、社会资源，良好的社会资源有利于患者应对各种健康问题，帮助其缓解症状，有利于提高生活质量。

思路 3：治疗：医学无法解释症状实行个性化治疗原则，治疗包括非药物治疗、药物治疗和认知行为疗法。

1. 非药物治疗　该女性患者平时缺乏锻炼，可进行有氧运动和力量训练，适度的运动可以改善乏力。运动可提高体力和耐力，也可促进内啡肽释放，减少肌肉疼痛，但早期运动可能加重乏力。可从低强度开始，随后逐渐增大强度。其他包括物理疗法、药浴、推拿、针灸等，适合于合并有慢性疼痛、腹胀的医学无法解释症状患者。

2. 药物治疗　目前尚无针对乏力的药物。对于因乏力而影响日常生活和工作的患者，低剂量纳曲酮对慢性疲劳综合征可能有一定的疗效，可缓解症状并提高患者的生活质量。恰当的治疗可以缓解症状，满足患者的部分就诊需求，提高生活质量。如使用匹维溴铵可以缓解腹胀、腹痛症状；普瑞巴林、非甾体抗炎药可以减轻慢性疼痛。如伴有焦虑障碍，抗焦虑药、抗抑郁药如度洛西汀、米那普仑可缓解症状。如有器质性基础疾病，尤其是慢性疾病，作为全科医师应该积极治疗原有疾病并对患者进行有效的健康管理，部分患者经过治疗后，症状得到缓解甚至消除。

3. 认知行为疗法　通过改变患者对疾病的不良认知，树立正确的疾病观和健康观，消除对疾病的恐惧、不良行为。通过倾听患者描述的症状、认同患者症状的真实性；对可能潜在的疾病或者患者自己认为的疾病进行合理的检查；与患者就其症状及检查结果进行共同探讨，解释医学原因；对症状严重性进行评估及预后分析，以达成共识并形成决策。

认知行为疗法是个性化的治疗方法，该疗法目的是：使患者明确和接受症状的存在，做好症状长

期伴随的心理准备；经过评估后，告知症状目前没有严重到影响生命，但可能影响生活质量；增强可以缓解症状的信心，但需要正确认识症状和某些疾病的关联性；药物治疗不一定能完全消除症状，但通过调节情绪、健康生活、从事力所能及的工作和改变就医行为，也可以缓解症状。如，偏头痛虽然无法根治但可以有效控制。协助患者增加对该病的认知，使其拥有理性的防治观念与目标；鼓励患者写头痛日记、学会寻找各种发病因素；注意避免不良行为及评价治疗效果，对预防发作和治疗有积极的意义。本例患者存在生活和工作压力，可以利用家庭、社会资源，充分沟通后，让患者客观认识压力的存在和实际程度，协商解决办法，缓解心理压力。

思路 4：全科医师健康教育：通过和患者的充分沟通，了解症状的诱因，进行个性化健康教育，在生活方式、工作方式、社会行为等方面进行健康教育，树立良好的个人行为（心态平和、劳逸结合）和健康生活方式（减重、运动、戒酒、戒烟、高质量睡眠等）。该患者摄入咖啡过多会影响睡眠，建议减少饮用。

思路 5：经过评估和治疗，仍须排除其他可能导致乏力的病因，针对可能潜在的疾病，结合伴随症状进一步完善检查，或者转诊。

知识点

乏力需要完善的辅助检查如下。

1. 实验室检查　心肌酶谱，排除肌炎、横纹肌溶解；病毒性肝炎、自身免疫性肝炎标志物，有助于排除肝病；电解质，有助于排除低钾血症、低钠血症等；自身免疫抗体，排除血管炎、干燥综合征等；肾上腺皮质激素水平，排除肾上腺皮质功能减退症。

2. 影像学检查　超声检查，排除腹部、子宫附件疾病。胸部 CT 检查、胃肠镜排除肿瘤。

3. 肌电图及神经传导检查　排除肌肉和周围神经病变。

【问题 8】乏力转诊的指征包括哪些？

患者经就诊、复诊治疗及管理后，症状无缓解且病情有加重趋势；不排除有严重疾病；存在特定疾病的预警症状；有精神疾病等。有以上情况，建议转专科就诊，或者转诊到上级医院进一步诊治。

医学无法解释症状患者的处理，需要全科医师正确运用全科诊断思维，通过详细采集病史、合理检查，排除其他疾病，作出正确诊断，并根据患者严重程度进行个性化管理。患者的管理是一个持续和综合过程，需要患者、家庭和社区多方面共同参与。通过药物治疗、改善生活习惯、认知行为治疗和健康教育，部分患者症状缓解，甚至康复。医学无法解释症状的处理见图 16-1。

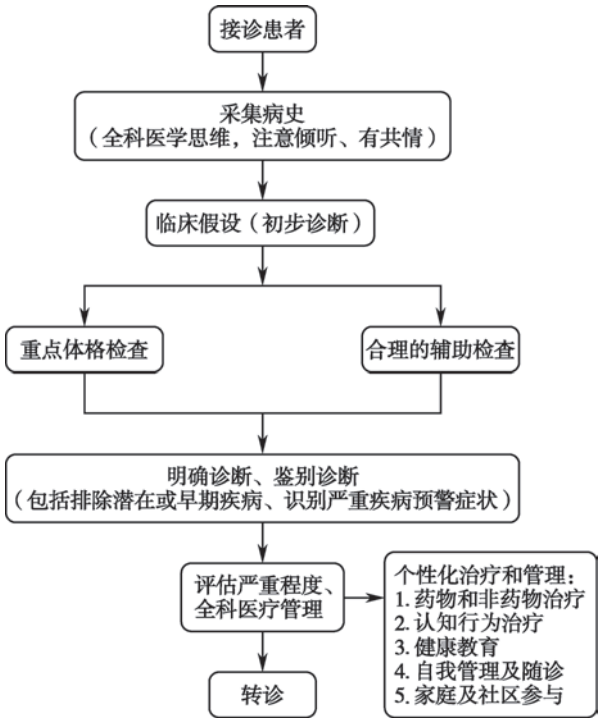


图 16-1　医学无法解释症状处理图

知识点

1. 医学无法解释症状的“无法解释”是相对的。

2. 有些症状可能属于疾病早期表现，与疾病的发展阶段有关，就诊时尚未能归属某种疾病。

3. 医学无法解释，是由于医学科学及技术水平有限，但随着医学检验技术、病理学技术的发展和应用，一些原本“无法解释”的症状，变得“可解释”；相反，有些在以前可以“解释”的症状，在新的医学理论和技术下，可能变得“不可解释”。

4. 随着医学发展，许多尚未解释的症状将得到合理解释。

（宁　宗）

思考题

1. 医学无法解释症状的特点有哪些？
2. 阐述医学无法解释症状诊断的基本原则。
3. 对医学无法解释症状患者的全科医学处理有哪些？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

NOTES